PANDUAN PRAKTIK KLINIS: STROKE ISKEMIK AKUT & TROMBOLISIS IV

Protokol Reperfusi Hiperakut r-tPA (Alteplase / Tenecteplase) & Trombektomi Mekanik

Kategori: Penyakit & Panduan	**Spesialisasi: Neurologi & Stroke**	**Kode ICD-10: I63.0 - I63.9**	**Level Bukti: AHA/ASA & ESO Level I-A**

1. Kriteria Golden Period & Skrining Hiperakut

Setiap menit penundaan terapi reperfusi stroke iskemik menyebabkan kematian ~1.9 juta neuron otak (*Time is Brain*). Jendela waktu terapi trombolisis intravena (IVT) menggunakan r-tPA adalah **dalam waktu 4.5 jam** sejak onset gejala defisit neurologis terakhir diketahui normal.

Evaluasi Segera di Unit Gawat Darurat:

- Skrining FAST (Face drooping, Arm weakness, Speech difficulty, Time to call).
- Penilaian Derajat Keparahan Stroke menggunakan **National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)**.
- **CT Scan Kepala Non-Kontras Cepat (Door-to-CT <20 menit):** Menyingkirkan perdarahan intrakranial (ICH) dan menghitung skor ASPECTS.
- **Batas Tekanan Darah Sebelum Trombolisis:** Tekanan darah harus diturunkan hingga < 185/110 mmHg (menggunakan Nicardipine atau Labetalol IV).

2. Dosis dan Protokol Administrasi r-tPA (Alteplase)

Dosis Total Alteplase: 0.9 mg/kg berat badan (Dosis maksimum 90 mg).
- **10% dari dosis total** diberikan sebagai Bolus Intravena dalam 1 menit.
- **90% sisa dosis** diberikan melalui Infus Kontinu menggunakan Syringe Pump selama 60 menit.
- *Alternatif Tenecteplase (TNK-tPA):* 0.25 mg/kg IV bolus tunggal (maksimum 25 mg) (Level I-A, AcT trial).

3. Kontraindikasi Mutlak Trombolisis IV

- Perdarahan intrakranial aktif pada CT scan.
- Riwayat trauma kepala berat atau bedah saraf dalam 3 bulan terakhir.
- Perdarahan internal aktif atau diastesis perdarahan (Trombosit < 100.000/uL, INR > 1.7, aPTT > 40 detik).
- Penggunaan antikoagulan oral langsung (DOAC) dalam 48 jam terakhir dengan kadar terapeutik.